

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | <b>CONSENTIMIENTO INFORMADO</b><br><b>NUTRICIÓN - NPT</b><br><small>(EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 23 DE 1981, DE LA RESOLUCIÓN 1995 DE 1999 Y DEMAS NORMAS RELACIONADAS CON LA HISTORIA CLÍNICA)</small> | <b>Código:</b> FT-HCR-07                            |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <b>Versión:</b> 01                                  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <b>Fecha de actualización:</b><br>noviembre de 2024 |

Fecha de diligenciamiento DÍA: \_\_\_\_\_ MES: \_\_\_\_\_ AÑO: \_\_\_\_\_

|                                                    |                 |                  |         |      |           |          |
|----------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------|------|-----------|----------|
| Paciente:                                          |                 |                  |         |      |           |          |
|                                                    | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Edad | Documento | Teléfono |
| Personal de Salud<br>Responsable del Procedimiento |                 |                  |         |      |           |          |
|                                                    | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres |      |           |          |

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO POR LA TOTALIDAD DEL TRATAMIENTO

Yo, \_\_\_\_\_, con numero de documento de identidad, \_\_\_\_\_ certifico que: He leído (o que se me han leído) el documento sobre Consentimiento Informado de **Nutrición parenteral – NPT** que contiene información sobre los procedimientos y actividades tendientes a alimentación intravenosa que proporciona nutrientes esenciales directamente al torrente sanguíneo.

**NUTRICIÓN PARENTERAL – NPT** es un procedimiento que se utiliza cuando el paciente no puede recibir una nutrición adecuada por vía oral o enteral (a través del tracto gastrointestinal). La nutrición parenteral incluye una mezcla de líquidos, electrolitos, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales, administrados a través de un catéter venoso central o periférico.

¿EN QUÉ LE BENEFICIARÁ?

**Provisión de Nutrientes Esenciales:** La nutrición parenteral asegura que el paciente reciba todos los nutrientes necesarios para mantener la salud y promover la recuperación. Esto es crucial para pacientes que no pueden alimentarse adecuadamente por otras vías, ayudando a prevenir la desnutrición y sus complicaciones.

**Mejora del Estado Nutricional:** La administración de nutrientes directamente en el torrente sanguíneo permite una absorción rápida y eficiente. Mejora el estado nutricional del paciente, lo que puede acelerar la recuperación y mejorar la respuesta a otros tratamientos médicos.

**Soporte en Condiciones Críticas:** La nutrición parenteral es vital para pacientes en estado crítico o con condiciones que impiden la alimentación oral o enteral, como obstrucciones intestinales, enfermedades inflamatorias del intestino, o postoperatorios complejos. Proporciona un soporte nutricional esencial que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones críticas.

RIESGOS:

**Infecciones:** El uso de catéteres venosos puede aumentar el riesgo de infecciones en el sitio de inserción. Mantener una higiene rigurosa y seguir protocolos de asepsia durante la inserción y el manejo del catéter.

**Complicaciones Metabólicas:** La nutrición parenteral puede causar desequilibrios electrolíticos, hiperglucemia, y deficiencias o excesos de nutrientes. Monitorear regularmente los niveles de electrolitos y ajustar la fórmula nutricional según sea necesario.

**Trombosis Venosa:** La inserción de catéteres venosos puede aumentar el riesgo de formación de coágulos sanguíneos. Utilizar técnicas adecuadas de inserción y manejo del catéter, y considerar el uso de anticoagulantes si es necesario.

**Complicaciones Hepáticas:** El uso prolongado de nutrición parenteral puede causar complicaciones hepáticas, como esteatosis hepática o colestasis. Monitorear la función hepática regularmente y ajustar la composición de la nutrición parenteral para minimizar el riesgo.

**Reacciones Alérgicas:** Algunos pacientes pueden experimentar reacciones alérgicas a los componentes de la nutrición parenteral. Realizar pruebas de alergia previas y monitorear al paciente durante la administración.

Otros: \_\_\_\_\_.

IMPLICACIONES - CONSECUENCIAS RELEVANTES O DE IMPORTANCIA:

La nutrición parenteral es una intervención médica compleja que implica la administración de nutrientes directamente en el torrente sanguíneo. Aunque es una herramienta vital para pacientes que no pueden recibir nutrición adecuada por vía oral o enteral, también conlleva varias implicaciones que deben ser cuidadosamente consideradas y gestionadas.

1. Implicaciones Fisiológicas

a. Metabolismo y Absorción: La nutrición parenteral proporciona nutrientes esenciales que son absorbidos directamente en el torrente sanguíneo, evitando el tracto gastrointestinal. Esto permite una absorción rápida y eficiente de nutrientes, pero también requiere un monitoreo constante para evitar desequilibrios metabólicos.

b. Función Hepática: La administración prolongada de nutrición parenteral puede afectar la función hepática, causando complicaciones como esteatosis hepática (acumulación de grasa en el hígado) o colestasis (reducción del flujo biliar). Es crucial monitorear regularmente la función hepática y ajustar la composición de la nutrición parenteral para minimizar estos riesgos.

2. Implicaciones Psicológicas y Sociales

a. Calidad de Vida: La nutrición parenteral puede mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes al proporcionar los nutrientes necesarios para mantener la salud y promover la recuperación. Sin embargo, puede ser una carga emocional y psicológica tanto para el paciente como para sus cuidadores, debido a la necesidad de cuidados continuos y la dependencia de equipos médicos.

b. Apoyo Emocional: Los pacientes y sus familias pueden experimentar ansiedad y estrés relacionados con la administración de la nutrición parenteral y el manejo de posibles complicaciones. Proporcionar apoyo emocional y recursos educativos puede ayudar a manejar estos desafíos y mejorar la adherencia al tratamiento.

3. Implicaciones Prácticas y Logísticas

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <b>CONSENTIMIENTO INFORMADO</b><br><b>NUTRICIÓN - NPT</b><br><small>(EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 23 DE 1981, DE LA RESOLUCIÓN 1995 DE 1999 Y DEMAS NORMAS RELACIONADAS CON LA HISTORIA CLÍNICA)</small> | Código: FT-HCR-07                            |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | Versión: 01                                  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | Fecha de actualización:<br>noviembre de 2024 |

a. Manejo del Catéter: La nutrición parenteral requiere la inserción y el mantenimiento de un catéter venoso central o periférico, lo que implica riesgos de infecciones y complicaciones mecánicas. Es esencial seguir protocolos estrictos de asepsia y monitorear el sitio de inserción para prevenir infecciones y otras complicaciones.

b. Monitoreo y Ajustes: La composición de la nutrición parenteral debe ser ajustada regularmente según las necesidades del paciente y los resultados de las pruebas de laboratorio. Esto requiere un monitoreo constante y la colaboración entre el equipo de salud para asegurar que el paciente reciba una nutrición adecuada y equilibrada.

**4. Implicaciones Económicas**

a. Costos del Tratamiento: La nutrición parenteral puede ser costosa debido a los equipos, los suministros y la necesidad de monitoreo continuo. Es importante considerar los costos y buscar opciones de financiamiento o cobertura de seguros para asegurar que el paciente pueda recibir el tratamiento necesario sin una carga financiera excesiva.

b. Recursos y Capacitación: La administración de nutrición parenteral en el hogar requiere recursos adecuados y la capacitación de los cuidadores para manejar el equipo y los procedimientos. Proporcionar la capacitación y los recursos necesarios puede mejorar la seguridad y la eficacia del tratamiento en el hogar.

**ALTERNATIVAS AL PROCEDIMIENTO**

**Nutrición Enteral:** Administración de nutrientes a través de una sonda que pasa por el tracto gastrointestinal. Es menos invasiva que la nutrición parenteral y puede ser una opción si el tracto gastrointestinal está funcional.

**Alimentación Oral:** Consumo de alimentos y suplementos nutricionales por vía oral. Es la forma más natural de alimentación, pero puede no ser viable para pacientes con ciertas condiciones médicas.

**Suplementos Nutricionales:** Uso de suplementos nutricionales específicos para complementar la dieta del paciente. Puede ser útil en casos de deficiencias nutricionales leves a moderadas, pero no es suficiente para pacientes con necesidades nutricionales complejas.

**ENTIENDO MI PLAN DE TRATAMIENTO Y CONSIENTO - ACEPTO -EN SER TRATADO POR EL PERSONAL DE SALUD**

|                                        |                                               |                                                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>HUELLA PACIENTE</b><br><br><br><br> |                                               |                                                          |
|                                        | <b>Firma del Paciente</b>                     | <b>Cedula del Paciente</b>                               |
|                                        |                                               |                                                          |
|                                        | <b>Firma y Cedula del acudiente o testigo</b> | <b>Firma y sello o registro del personal de la salud</b> |

| <b><u>NO CONSENTIMIENTO</u></b>                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Con pleno conocimiento de los riesgos y después de haber sido informado, he decidido <b>no aceptar</b> la realización del procedimiento, haciéndome responsable de las consecuencias que se puedan derivar de esta decisión. |                                                          |                                               |
| <b>HUELLA PACIENTE</b><br><br><br><br>                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>Firma y cedula del Paciente</b>                       | <b>Firma y cedula del acudiente o testigo</b> |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>Firma y sello o registro del personal de la salud</b> |                                               |